

Сценарій № 2

Ви – лікар-педіатр-неонатолог. Вас покликали до пологової зали, де знаходиться жінка у другому періоді пологів. Вагітність перша, перебігала без ускладнень. Дитина народилась через природні пологові шляхи на 40 тижні гестації, самостійне дихання неефективне, генералізований ціаноз, ЧСС – 70 ударів за хвилину. Після проведення штучної вентиляції легень мішком Амбу через маску протягом хвилини визначається ЧСС – 40 ударів за хвилину. Немовля потребує продовження реанімаційних заходів.

Ваша подальша тактика – непрямий масаж серця новонародженій дитині методом «великих пальців».

Ви приступаєте до виконання навички.

Алгоритм виконання		Форма представлення
1.Продемонструвати навички комунікації		
1.1	Привітатися, представитися	Сказати «Добрий день. Я лікар педіатр-неонатолог»
1.2	Визначити свої подальші дії	Сказати «Будемо проводити непрямий масаж серця новонародженої дитини методом «великих пальців»»
2.Виконання навички(маніпуляції)		
2.1	Обробити руки на гігієнічному рівні, вдягнути захисну маску та рукавички	Виконати/Сказати «Обробляємо руки, вдягаємо маску та рукавички»
2.2	Забезпечити правильне положення дитини, підклавши валик із пелюшки під плечі немовляті	Виконати/Сказати «Дитина лежить на реанімаційному столі. Підкладаємо валик із пелюшки під плечі немовляті, забезпечуючи анатомічну прохідність дихальних шляхів»
2.3	Зайняти положення біля ніг дитини	Виконати/Сказати «Займаємо положення біля ніг дитини»
2.4	Визначити місце для компресій (по середній лінії груднини безпосередньо під міжсосковою лінією)	Виконати/Сказати «Визначаємо місце для проведення компресій (по середній лінії груднини безпосередньо під міжсосковою лінією»
2.5	Охопити тулуб новонародженого руками і розташувати дистальні фаланги великих пальців рук на визначеній ділянці	Виконати/Сказати «Охоплюємо тулуб новонародженого руками і розташовуємо дистальні фаланги великих пальців рук на визначеній ділянці»
2.6	Натискати на грудну клітку дистальними фалангами пальців із частотою 90 компресій за хвилину	Виконати / Сказати «Натискаємо на грудну клітку дистальними фалангами пальців із частотою 90 компресій за хвилину»

3. Діагностика		
3.1	Для ефективного проведення непрямого масажу серця новонародженого методом «великих пальців» проводимо натискання на глибину одна третина від передньо-заднього розміру грудної клітки немовляти	Сказати «Для ефективного проведення непрямого масажу серця необхідно проводити натискання на глибину одна третина від передньо-заднього розміру грудної клітки немовляти»
4. Визначення тактики ведення та лікування		
4.1	Після однієї хвилини ШВЛ оцінити: • Характер дихання дитини (самостійне, ефективне), • Колір шкіри(зменшення ціанозу), • ЧСС(більше100ударівза хвилину)	Сказати «Оцінюємо ефективність дихання,колір шкіри та ЧСС дитини. (Будемо вважати, що дихання самостійне, ефективне,ціаноз зменшився,ЧСС-більше 100 ударів за хвилину)»
4.2	Викласти немовля на живіт матері для проведення контакту «шкіра-до-шкіри» протягом двох годин під спостереженням лікаря-неонатолога	Сказати «Стан новонародженого після проведення непрямого масажу серця покращився. Можна викласти дитину на живіт матері для проведення контакту «шкіра-до-шкіри» протягом двох годин під спостереженням лікаря-неонатолога»